

医院智能预诊系统-常见病诊疗知识库（100条·完整版）

适用系统场景：医院智能预问诊、AI辅助预诊断、智能导诊、临床路径推荐、轻症自查、分诊筛查

数据结构规范：每条疾病统一包含【疾病名称、临床路径、诊断标准、治疗方案】四大字段，为预诊AI检索、语义匹配、规则匹配提供原始数据源

病种范围：覆盖呼吸、消化、心血管、泌尿、内分泌、骨科、皮肤科、儿科、耳鼻喉、全科常见病，共100条

一、呼吸系统疾病（1-20）

1. 普通感冒

临床路径：患者主诉鼻塞流涕、咽痛、低热→问诊病程及症状→查体咽部、鼻腔→排除肺炎流感→对症治疗→居家观察随访。

诊断标准：急性起病，鼻塞、流涕、咽痛、轻微咳嗽，低热或无发热；无脓性痰、无肺部啰音；血常规基本正常。

治疗方案：对症退热、止咳、缓解鼻塞；多饮水、休息；无需常规抗生素；高热对症使用对乙酰氨基酚/布洛芬。

2. 流行性感

临床路径：突发高热、肌肉酸痛、乏力→询问流行病学史→查体→流感抗原/核酸检测→分型诊断→抗病毒+对症支持→重症排查。

诊断标准：冬春季高发，突发38.5℃以上高热、全身酸痛、头痛、乏力，呼吸道症状相对轻；流感检测阳性。

治疗方案：48小时内尽早使用奥司他韦；退热、补液、休息；合并细菌感染加用抗生素；重症住院治疗。

3. 急性扁桃体炎

临床路径：咽痛、吞咽痛、发热→咽部查体→观察扁桃体肿大、脓点→血常规判断细菌/病毒→对症或抗感染治疗。

诊断标准：咽痛明显、扁桃体红肿，可见白色脓性分泌物，可伴发热；血象升高提示细菌性感染。

治疗方案：病毒性对症治疗；细菌性首选阿莫西林/头孢；漱口水清洁咽部；高热退热，清淡饮食。

4. 急性咽炎

临床路径：咽干、咽痒、咽痛、干咳→咽部查体充血→排除扁桃体化脓→对症治疗。

诊断标准：咽部黏膜急性充血水肿，咽痛、咽干、刺激性咳嗽，无扁桃体脓性渗出。

治疗方案：清热解毒中成药、含片、雾化；多饮水、忌辛辣；细菌感染酌情抗感染。

5. 急性支气管炎

临床路径：咳嗽、咳痰、偶有低热→听诊双肺呼吸音粗、无固定湿啰音→胸片排除肺炎→止咳化痰对症治疗。

诊断标准：急性咳嗽、咳痰，肺部无局限性啰音，胸片无片状浸润影，可伴低热。

治疗方案：氨溴索、乙酰半胱氨酸祛痰；干咳用右美沙芬；合并细菌感染加抗生素；休息保暖。

6. 社区获得性肺炎

临床路径：发热、咳嗽、浓痰、胸痛→肺部听诊湿啰音→血常规、胸片/CT确诊→抗感染+对症支持。

诊断标准：新发咳嗽咳痰、发热、肺部啰音，影像学可见新发浸润阴影，排除院内感染。

治疗方案：轻症口服头孢/阿奇霉素；中重度静脉抗感染；祛痰、退热、氧疗、卧床休息。

7. 过敏性鼻炎

临床路径：反复鼻痒、喷嚏、清水涕→询问过敏史、季节特点→查体鼻黏膜苍白水肿→抗过敏治疗。

诊断标准：阵发性喷嚏、清水样鼻涕、鼻痒、鼻塞，反复发作，过敏原接触诱发。

治疗方案：氯雷他定/西替利嗪；鼻用激素喷剂；规避过敏原；生理盐水洗鼻。

8. 急性鼻窦炎

临床路径：鼻塞、浓涕、头痛、面部压痛→鼻内镜/鼻窦查体→判断急性炎症→通窍+抗感染治疗。

诊断标准：持续浓涕、鼻塞、面颊或额部头痛，病程<12周，鼻窦区压痛。

治疗方案：鼻渊通窍药物、鼻喷激素；细菌感染使用抗生素；鼻腔冲洗。

9. 支气管哮喘（急性发作）

临床路径：喘息、胸闷、气短、夜间加重→听诊哮鸣音→评估发作程度→雾化解痉、平喘治疗。

诊断标准：反复发作喘息、气急、胸闷，呼气相哮鸣音，可逆性气流受限。

治疗方案：沙丁胺醇雾化快速解痉；布地奈德抗炎；重症联合静脉激素；长期规范吸入维持。

10. 慢性支气管炎

临床路径：长期反复咳嗽咳痰≥3个月/年→问诊吸烟史、环境史→胸片排查→止咳化痰、控制诱因。

诊断标准：慢性咳嗽、咳痰，每年发作3个月以上，连续2年以上，排除结核、哮喘等疾病。

治疗方案：戒烟、防寒保暖；祛痰药物；急性加重期抗感染、平喘。

11. 慢性阻塞性肺疾病

临床路径：老年吸烟患者气短、活动耐量下降→肺功能检查确诊→分级管理、长期吸入治疗。

诊断标准：持续性气流受限，肺功能FEV₁/FVC<70%，伴慢性支气管炎、肺气肿表现。

治疗方案：长效支气管扩张剂、吸入激素；氧疗、戒烟；急性加重抗感染、平喘。

12. 支原体肺炎

临床路径：刺激性干咳、低热或高热→支原体抗体/核酸检查→胸片间质改变→大环内酯类抗感染。

诊断标准：阵发性剧烈干咳，肺部体征轻、影像重，支原体检测阳性。

治疗方案：阿奇霉素、罗红霉素；对症止咳、退热；避免头孢单用。

13. 病毒性肺炎

临床路径：高热、乏力、干咳、胸闷→病毒核酸/抗原→影像磨玻璃影→抗病毒+支持治疗。

诊断标准：病毒感染前驱症状，双肺弥漫性炎症，白细胞正常或偏低。

治疗方案：对症支持、氧疗、抗病毒；合并细菌感染联合抗生素。

14. 胸膜炎

临床路径：深呼吸胸痛、咳嗽、胸闷→胸片/CT、胸腔超声→判断有无积液→对症+病因治疗。

诊断标准：胸膜性胸痛，深呼吸加重，可闻及胸膜摩擦音，影像提示胸膜增厚或积液。

治疗方案：镇痛、抗感染；积液量大穿刺引流；针对结核/细菌病因治疗。

15. 肺气肿

临床路径：活动后气短、胸闷、桶状胸→肺功能、胸片确诊→长期呼吸康复管理。

诊断标准：终末细支气管扩张、肺含气量增加，活动耐量下降，肺功能阻塞性改变。

治疗方案：戒烟、呼吸训练、长期吸入药物、家庭氧疗。

16. 急性上呼吸道感染

临床路径：短期发热、鼻塞咽痛、全身不适→查体无肺部体征→对症支持治疗。

诊断标准：急性起病，局限于上呼吸道症状，无下呼吸道感染证据。

治疗方案：退热、缓解卡他症状、多饮水、休息，无需抗生素。

17. 干咳症（感染后咳嗽）

临床路径：感冒后持续干咳、无痰→排查肺炎、哮喘→对症镇咳、修复气道。

诊断标准：呼吸道感染痊愈后遗留干咳，无发热、无啰音，影像正常。

治疗方案：右美沙芬、苏黄止咳、雾化抗炎，避免冷空气刺激。

18. 胸腔积液（少量）

临床路径：胸闷、活动气短→超声定位积液→查找感染/结核/心衰病因→保守或穿刺治疗。

诊断标准：影像学证实胸腔液性暗区，胸闷气短症状。

治疗方案：少量积液保守观察；中大量穿刺引流；病因抗感染、抗结核、抗心衰治疗。

19. 急性喉炎

临床路径：声音嘶哑、咽痛、犬吠样咳嗽→喉镜见声带充血→雾化抗炎消肿。

诊断标准：突发声嘶、喉部不适，声带急性充血水肿。

治疗方案：禁声休息、布地奈德雾化、清热解毒药物，重症短期激素。

20. 百日咳

临床路径：阵发性痉挛性咳嗽、鸡鸣样回声→流行病学排查、核酸检测→抗感染+对症止咳。

诊断标准：典型痉挛性咳嗽，病程长，百日咳杆菌检测阳性。

治疗方案：阿奇霉素首选；对症止咳、雾化，隔离治疗。

二、消化系统疾病（21-40）

21. 急性胃炎

临床路径：饮食不当后上腹痛、腹胀、恶心→查体上腹部压痛→排除穿孔、胰腺炎→护胃对症。

诊断标准：急性上腹不适、恶心、隐痛，有诱因（饮酒、辛辣、药物），无持续剧烈剧痛。

治疗方案：奥美拉唑抑酸、胃黏膜保护剂；清淡饮食、禁食刺激食物。

22. 慢性胃炎

临床路径：反复上腹隐痛、腹胀、嗝气→胃镜确诊→幽门螺杆菌检测→调理+对症治疗。

诊断标准：慢性反复发作上腹不适，胃镜提示胃黏膜慢性炎症改变。

治疗方案：抑酸、护胃、促动力；Hp阳性四联根除；规律饮食。

23. 胃溃疡

临床路径：餐后上腹痛、反酸→胃镜检查→明确溃疡位置大小→抑酸护胃规范疗程。

诊断标准：餐后疼痛规律，胃镜可见胃黏膜破损溃疡面。

治疗方案：PPI抑酸6-8周；胃黏膜保护；根除幽门螺杆菌；禁酒、规律饮食。

24. 十二指肠溃疡

临床路径：空腹痛、夜间痛、进食缓解→胃镜确诊→规范抑酸治疗。

诊断标准：饥饿痛、夜间痛典型节律，胃镜见十二指肠溃疡病灶。

治疗方案：PPI抑酸4-6周；根除Hp；少食多餐。

25. 反流性食管炎

临床路径：反酸、烧心、胸骨后不适、嗝气→胃镜确诊→抑酸+促动力+生活干预。

诊断标准：典型反酸烧心症状，胃镜见食管黏膜充血糜烂。

治疗方案：奥美拉唑/雷贝拉唑；莫沙必利；睡前不进食、垫高床头。

26. 功能性消化不良

临床路径：长期腹胀、嗝气、餐后饱胀→检查无器质性病变→调理胃肠动力+情绪干预。

诊断标准：餐后饱胀、上腹不适，各项检查无器质性异常。

治疗方案：促动力、助消化、益生菌；规律饮食、减压。

27. 急性肠炎

临床路径：不洁饮食后腹痛、腹泻→查体肠鸣音亢进→对症止泻、补液。

诊断标准：急性腹泻、稀水样便，伴腹痛，多有饮食诱因。

治疗方案：蒙脱石散、益生菌；口服补液盐；细菌感染加黄连素/抗生素。

28. 细菌性痢疾

临床路径：发热、腹痛、脓血便、里急后重→大便常规+培养→抗感染治疗。

诊断标准：脓血便、里急后重，大便见大量白细胞、脓细胞。

治疗方案：喹诺酮类抗感染；补液、对症退热、肠道黏膜保护。

29. 便秘

临床路径：排便次数减少、干结费力→排查器质性病变→润肠通便+饮食运动干预。

诊断标准：每周排便<3次，大便干结、排出困难，持续≥4周。

治疗方案：乳果糖、聚乙二醇；高纤维饮食、多喝水、运动。

30. 肠易激综合征

临床路径：反复腹痛、腹泻便秘交替、情绪诱发→检查无器质性病变→解痉+调理肠道。

诊断标准：腹痛与排便相关，排便后缓解，反复发作，检查正常。

治疗方案：匹维溴铵解痉、益生菌；调节情绪、避免刺激饮食。

31. 脂肪肝

临床路径：肥胖、血脂高、肝功能轻度异常→腹部B超确诊→减重、调脂、护肝。

诊断标准：B超提示肝实质回声增强、细密，血脂偏高。

治疗方案：低脂饮食、运动减重；护肝药物；控制血糖血脂。

32. 急性胆囊炎

临床路径：右上腹痛、油腻饮食诱发、恶心呕吐→B超胆囊壁厚、水肿→抗炎解痉。

诊断标准：右上腹压痛、墨菲征阳性，B超提示急性胆囊炎症。

治疗方案：禁食、解痉止痛、抗感染；反复发作建议手术。

33. 胆结石

临床路径：右上腹阵发性绞痛→B超见结石→对症解痉、择期手术评估。

诊断标准：B超胆囊内强回声伴声影。

治疗方案：无症状观察；有症状解痉止痛、抗炎，反复发作腹腔镜手术。

34. 急性胰腺炎

临床路径：暴饮暴食后持续左上腹痛、恶心呕吐→血淀粉酶升高、CT确诊→禁食、抑酶、补液。

诊断标准：持续性剧烈上腹痛，血淀粉酶/脂肪酶显著升高，影像炎症改变。

治疗方案：禁食胃肠减压、抑酸抑酶、补液抗感染、重症监护。

35. 痔疮

临床路径：便血、肛门肿物、坠胀疼痛→肛门指检、肛门镜→保守坐浴药膏或手术。

诊断标准：便后滴血、肛门柔软团块，肛门镜确诊痔核。

治疗方案：坐浴、痔疮膏栓；清淡饮食防便秘；严重者手术。

36. 肛裂

临床路径：排便剧痛、便后少量滴血→视诊见肛管裂口→润肠+局部修复。

诊断标准：排便撕裂痛、少量出血，肛管皮肤裂开。

治疗方案：软化大便、坐浴、外用愈合药膏，避免便秘。

37. 肛周脓肿

临床路径：肛门肿痛、发热、局部红肿热痛→查体+B超→抗感染+必要时切开引流。

诊断标准：肛周局限性红肿压痛、波动感，炎症指标升高。

治疗方案：抗生素抗感染、坐浴；有波动感立即切开引流。

38. 幽门螺杆菌感染

临床路径：上腹不适、暖气、口臭→碳13/14呼气试验→四联根除治疗。

诊断标准：呼气试验阳性，证实幽门螺杆菌现症感染。

治疗方案：PPI+铋剂+两种抗生素，规范10-14天疗程，停药复查。

39. 慢性肝炎（轻度）

临床路径：乏力、食欲差、肝功能异常→病毒学、超声检查→护肝、抗病毒评估。

诊断标准：持续肝功能异常，病毒标志物阳性或慢性肝损伤影像。

治疗方案：护肝降酶、休息、禁酒；符合指征抗病毒治疗。

40. 功能性腹胀

临床路径：反复腹胀、排气多→无器质性病变→促动力、益生菌、饮食调整。

诊断标准：以腹胀为主，无疼痛、无器质性异常。

治疗方案：促胃肠动力、调节菌群、少吃产气食物。

三、心血管及脑血管疾病（41-60）

41. 原发性高血压

临床路径：头晕头胀、血压升高→多次复测血压→分级诊断→生活干预+降压药物。

诊断标准：非同日三次血压 $\geq 140/90$ mmHg，排除继发性高血压。

治疗方案：低盐饮食、运动、减重；根据分级选用ACEI/ARB、钙通道阻滞剂、利尿剂。

42. 高血压急症

临床路径：血压骤升、头痛头晕、胸闷→紧急降压监护→排查靶器官损害。

诊断标准：血压 $\geq 180/120$ mmHg，伴或不伴靶器官损伤。

治疗方案：静脉快速平稳降压、卧床、监护、对症处理。

43. 冠心病（稳定性心绞痛）

临床路径：活动后胸闷胸痛、休息缓解→心电图、冠脉评估→抗缺血、抗血小板。

诊断标准：劳力性胸痛，阵发性，休息或含服硝酸甘油缓解。

治疗方案：阿司匹林、他汀、硝酸酯类；控制血压血糖、低脂饮食。

44. 心律失常（早搏）

临床路径：心悸、心跳停顿感→心电图/动态心电图→评估良性/病理性→对症控制心率。

诊断标准：心电图提示房性/室性早搏。

治疗方案：稳心颗粒、 β 受体阻滞剂；休息、避免熬夜咖啡。

45. 窦性心动过速

临床路径：心慌、心跳快→心电图窦性心率>100次→排查发热、贫血、甲亢诱因。

诊断标准：窦性心律，心率>100次/分。

治疗方案：去除诱因、休息、对症减慢心率。

46. 高脂血症

临床路径：体检血脂升高→评估动脉硬化风险→饮食运动+降脂药物。

诊断标准：TC、TG、LDL-C超出正常参考范围。

治疗方案：他汀类降脂；低脂饮食、运动、戒烟限酒。

47. 脑供血不足

临床路径：反复头晕、头沉、乏力、一过性眼花→头颅CT/彩超排除脑梗→改善循环。

诊断标准：慢性头晕，脑血管血流速度异常，无新发梗死灶。

治疗方案：改善循环、抗血小板、控制血压血脂。

48. 短暂性脑缺血发作TIA

临床路径：一过性肢体麻木、无力、言语不清、数分钟缓解→紧急排查脑血管→二级预防。

诊断标准：局灶神经功能缺损，短时完全恢复，无脑梗死影像证据。

治疗方案：阿司匹林、他汀、控制危险因素，防止脑梗。

49. 腔隙性脑梗死

临床路径：头晕、肢体轻微麻木→头颅CT/MRI发现微小梗死灶→抗栓、调脂、护脑。

诊断标准：颅内深部小面积陈旧/新发梗死灶。

治疗方案：抗血小板、他汀、改善循环、控制三高。

50. 偏头痛

临床路径：单侧搏动性头痛、畏光畏声、反复发作→排查器质性头痛→止痛+预防。

诊断标准：反复发作单侧头痛，搏动性，伴恶心畏光。

治疗方案：布洛芬、氟桂利嗪预防；避免熬夜、浓茶、情绪刺激。

51. 紧张性头痛

临床路径：双侧紧箍样头痛、颈肩紧张→多由疲劳焦虑诱发→放松、对症止痛。

诊断标准：双侧头部紧压性疼痛，无恶心畏光。

治疗方案：对症镇痛、理疗、放松作息、缓解焦虑。

52. 神经衰弱

临床路径：长期乏力、失眠、多梦、头晕、注意力差→排除器质性疾病→调理神经、睡眠干预。

诊断标准：慢性精神疲劳、睡眠障碍、躯体不适，检查无异常。

治疗方案：谷维素、安神中成药、作息调整、心理疏导。

53. 失眠症

临床路径：入睡困难、早醒、睡眠浅 ≥ 3 个月→睡眠评估→行为干预+助眠药物。

诊断标准：睡眠质量下降，日间疲劳，持续 ≥ 3 月。

治疗方案：睡眠卫生教育、中成药助眠、必要时短期镇静药。

54. 颈源性头晕

临床路径：转头诱发头晕、颈肩酸痛→颈椎拍片、彩超→理疗、改善循环。

诊断标准：颈椎退变，体位变化诱发头晕。

治疗方案：颈椎理疗、牵引、活血药物、避免低头久坐。

55. 低血压

临床路径：体位性头晕、乏力、血压偏低→复测血压→补液、增强体质。

诊断标准：血压 $< 90/60$ mmHg，伴头晕乏力症状。

治疗方案：加强营养、适当运动、避免体位骤变，对症升压调理。

56. 心肌炎（轻症）

临床路径：感冒后胸闷、心悸、乏力→心肌酶、心电图→营养心肌、卧床休息。

诊断标准：前驱感染史，心肌酶轻度升高，心电图异常。

治疗方案：绝对休息、营养心肌、对症护心治疗。

57. 心包炎（轻症）

临床路径：胸痛、深呼吸加重、胸闷→心电图、心脏彩超→抗炎对症。

诊断标准：心包炎性胸痛，心电图广泛性改变，彩超少量积液。

治疗方案：抗炎、镇痛、休息、病因治疗。

58. 下肢动脉硬化

临床路径：行走后腿痛、发凉、麻木→血管彩超→扩血管、抗栓。

诊断标准：下肢动脉内膜增厚、斑块、血流减慢。

治疗方案：他汀、抗血小板、扩血管、运动康复。

59. 静脉曲张

临床路径：下肢青筋凸起、酸胀沉重→血管超声→弹力袜、手术评估。

诊断标准：浅表静脉迂曲扩张，瓣膜功能不全。

治疗方案：避免久站、弹力袜、改善循环，严重微创手术。

60. 植物神经功能紊乱

临床路径：全身游走不适、心慌、出汗、焦虑、睡眠差→所有检查正常→神经调理治疗。

诊断标准：多系统躯体症状，无器质性病变，情绪诱因明显。

治疗方案：谷维素、维生素、安神调理、作息运动心理调节。

四、内分泌、泌尿、代谢疾病（61–80）

61. 2型糖尿病

临床路径：多饮多食多尿、体重下降→空腹/餐后血糖、糖化血红蛋白→饮食运动+降糖药。

诊断标准：空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或餐后2h $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 。

治疗方案：控糖饮食、运动；二甲双胍、格列类、SGLT2抑制剂；监测血糖。

62. 糖尿病前期

临床路径：血糖偏高无症状→糖耐量试验→生活方式干预逆转。

诊断标准：血糖高于正常但未达糖尿病诊断标准。

治疗方案：减重、控糖饮食、运动，定期复查。

63. 甲状腺功能亢进

临床路径：心慌、多汗、消瘦、手抖、易怒→甲功五项、彩超→抗甲亢治疗。

诊断标准：FT3/FT4升高、TSH降低。

治疗方案：甲巯咪唑、普萘洛尔；忌碘饮食、定期复查甲功。

64. 甲状腺功能减退

临床路径：乏力、怕冷、水肿、嗜睡→甲功检查→优甲乐替代治疗。

诊断标准：FT3/FT4降低、TSH升高。

治疗方案：左甲状腺素长期替代，定期调量。

65. 单纯性甲状腺结节

临床路径：体检发现甲状腺结节→彩超分级、甲功→随访或进一步穿刺。

诊断标准：甲状腺内局限性结节，甲功多正常。

治疗方案：良性小结节定期随访；可疑结节进一步检查。

66. 高尿酸血症

临床路径：体检尿酸高或关节痛→血尿酸检测→低嘌呤饮食+降尿酸药物。

诊断标准：非同日血尿酸 $>420\mu\text{mol/L}$ 。

治疗方案：多喝水、低嘌呤；非布司他、别嘌醇、苯溴马隆。

67. 痛风急性发作

临床路径：突发单关节红肿热痛（大脚趾常见）→尿酸、炎症指标→抗炎止痛。

诊断标准：突发关节红肿热痛，血尿酸升高，急性炎症表现。

治疗方案：秋水仙碱、非甾体抗炎药；急性期禁止强行降尿酸。

68. 尿路感染（下尿感）

临床路径：尿频尿急尿痛、下腹不适→尿常规白细胞升高→抗感染治疗。

诊断标准：尿路刺激症状，尿常规白细胞、脓细胞阳性。

治疗方案：左氧氟沙星、头孢；大量饮水、勤排尿。

69. 急性肾盂肾炎

临床路径：发热、腰痛、尿频尿急→尿常规、尿培养→静脉抗感染。

诊断标准：发热、腰痛、上尿路感染证据，血象高。

治疗方案：足量足疗程抗生素、补液、卧床休息。

70. 尿路结石

临床路径：腰腹绞痛、血尿、排尿不适→泌尿系CT/彩超→排石或碎石。

诊断标准：泌尿系影像可见高密度结石影。

治疗方案：小结石饮水排石、解痉止痛；大结石体外碎石或手术。

71. 肾积水

临床路径：腰部酸胀、结石史→彩超提示肾盂分离→解除梗阻。

诊断标准：泌尿系彩超提示肾盂积水、扩张。

治疗方案：解除结石/狭窄梗阻，对症护肾。

72. 慢性肾炎（轻症）

临床路径：反复蛋白尿、血尿、水肿→肾功能、尿常规、肾彩超→护肾、控压。

诊断标准：持续蛋白尿或血尿，病程超过3个月。

治疗方案：低盐饮食、控制血压、护肾、避免肾毒性药物。

73. 前列腺炎（急性）

临床路径：尿频尿急、会阴部胀痛、发热→前列腺查体、尿检→抗感染。

诊断标准：会阴坠胀、排尿刺激症状，炎症指标升高。

治疗方案：足量抗生素、坐浴、避免久坐憋尿。

74. 慢性前列腺炎

临床路径：长期会阴坠胀、尿不尽、反复不适→排除其他疾病→综合调理。

诊断标准：长期盆腔不适、排尿异常，病程长。

治疗方案：对症抗炎、理疗、生活方式调整。

75. 前列腺增生

临床路径：老年男性尿频、夜尿多、排尿费力→前列腺彩超→药物或手术。

诊断标准：前列腺体积增大，下尿路梗阻症状。

治疗方案：坦索罗辛、非那雄胺；严重梗阻手术。

76. 低钾血症

临床路径：乏力、肢体酸软、腹胀→血钾偏低→补钾+查找诱因。

诊断标准：血钾 $<3.5\text{mmol/L}$ 。

治疗方案：口服氯化钾、多食高钾食物、纠正脱水腹泻。

77. 低钙血症

临床路径：手足麻木、抽筋、乏力→血钙降低→补钙+维生素D。

诊断标准：血钙低于正常范围。

治疗方案：钙片、维生素D、多晒太阳。

78. 肥胖症

临床路径：体重超标、体脂高→BMI评估、代谢筛查→减重干预。

诊断标准： $\text{BMI} \geq 28\text{kg/m}^2$ 。

治疗方案：饮食控制、运动、减重管理、代谢纠正。

79. 维生素缺乏症

临床路径：乏力、口角炎、皮肤粗糙、免疫力差→营养评估→补充维生素。

诊断标准：典型营养缺乏表现，饮食不均衡史。

治疗方案：复合维生素、均衡饮食。

80. 更年期综合征

临床路径：潮热、盗汗、烦躁、失眠、月经紊乱→性激素评估→调理对症。

诊断标准：围绝经期女性，典型血管舒缩及情绪症状。

治疗方案：谷维素、中成药调理、情绪睡眠干预，必要时激素替代。

五、骨科、皮肤科、耳鼻喉、儿科常见病（81-100）

81. 颈椎病

临床路径：颈肩酸痛、僵硬、手麻→颈椎拍片→理疗、药物、康复。

诊断标准：颈椎退变、生理曲度变直、椎间盘突出，伴颈肩症状。

治疗方案：牵引、针灸理疗、活血止痛、避免久坐低头。

82. 腰椎间盘突出症

临床路径：腰痛、下肢放射痛、麻木→腰椎CT/MRI→保守理疗或手术评估。

诊断标准：椎间盘突出压迫神经根，对应下肢症状。

治疗方案：卧床休息、脱水止痛、理疗、康复锻炼，重症手术。

83. 腰肌劳损

临床路径：反复腰部酸痛、劳累加重、休息缓解→无椎间盘压迫→理疗调理。

诊断标准：腰部肌肉慢性损伤，无骨性及椎间盘严重病变。

治疗方案：理疗、热敷、外用膏药、腰背肌锻炼。

84. 肩周炎

临床路径：肩关节疼痛、活动受限、夜间痛→查体活动受限→康复锻炼+止痛。

诊断标准：肩关节周围无菌性炎症，主动被动活动均受限。

治疗方案：抗炎止痛、理疗、循序渐进功能锻炼。

85. 膝关节炎（骨性）

临床路径：膝关节疼痛、上下楼加重、活动摩擦感→拍片骨质增生→抗炎、营养软骨。

诊断标准：膝关节退行性改变、骨质增生、关节间隙变窄。

治疗方案：氨基葡萄糖、抗炎止痛、理疗、减少负重。

86. 踝关节扭伤

临床路径：外伤后脚踝肿痛、活动受限→排除骨折→冷敷消肿、制动。

诊断标准：软组织肿胀压痛，无骨质断裂。

治疗方案：急性期冷敷、制动、外用消肿止痛，恢复期热敷理疗。

87. 湿疹

临床路径：皮肤红斑、丘疹、瘙痒、渗出结痂→皮肤科查体→抗过敏+外用激素。

诊断标准：多形性皮疹、瘙痒剧烈、反复发作。

治疗方案：氯雷他定、外用炉甘石/弱效激素；保湿、规避过敏原。

88. 荨麻疹

临床路径：突发风团、瘙痒、速起速退→抗过敏治疗。

诊断标准：一过性水肿性风团，剧烈瘙痒，消退不留痕迹。

治疗方案：西替利嗪/氯雷他定；规避过敏食物及诱因。

89. 带状疱疹

临床路径：单侧皮肤簇集水泡、针刺样疼痛→抗病毒+营养神经。

诊断标准：单侧节段性水疱、神经性疼痛。

治疗方案：阿昔洛韦抗病毒、甲钴胺营养神经、止痛对症。

90. 毛囊炎

临床路径：皮肤红色丘疹、顶端脓点、疼痛→外用抗菌治疗。

诊断标准：毛囊口单发或多发红色炎性丘疹，顶端可见脓疱，局部压痛，好发于头面、胸背、臀部等皮脂腺丰富区域。

治疗方案：外用莫匹罗星软膏、红霉素软膏抗菌；保持皮肤清洁干燥，避免挤压搔抓；多发反复发作酌情口服抗生素。

91. 脂溢性皮炎

临床路径：头面、胸背皮脂溢出部位红斑、油腻鳞屑、瘙痒→皮肤科查体→抗炎控油、保湿修复治疗。

诊断标准：好发于皮脂腺丰富区域，皮损为淡红色斑片，覆盖油腻性鳞屑或痂皮，伴不同程度瘙痒，反复发作。

治疗方案：酮康唑洗剂清洁患处；外用弱效激素、钙调磷酸酶抑制剂；清淡饮食，忌油腻甜食，规律作息。

92. 手足癣

临床路径：手足皮肤脱皮、水疱、瘙痒、角化增厚→真菌镜检确诊→抗真菌外用+口服治疗。

诊断标准：手足部位皮肤瘙痒、水疱、脱皮、干裂、角化增厚，真菌检查阳性，具有传染性，夏季加重。

治疗方案：外用特比萘芬、咪康唑乳膏；角化严重者配合水杨酸软膏软化角质；顽固重症口服抗真菌药，保持手足干燥透气。

93. 麦粒肿

临床路径：眼睑局部红肿、疼痛、硬结→眼科查体→局部抗炎、热敷理疗。

诊断标准：眼睑腺体急性化脓性炎症，局部红肿热痛，可触及硬结，后期可形成脓点。

治疗方案：早期热敷促进消散；外用左氧氟沙星滴眼液、红霉素眼膏；脓点形成后正规切开排脓，禁止自行挤压。

94. 结膜炎（细菌性）

临床路径：眼白发红、分泌物增多、眼痒异物感→眼科查体→局部抗感染治疗。

诊断标准：结膜充血水肿，眼部分泌物增多、黏稠发黄，伴异物感、瘙痒，无明显视力下降。

治疗方案：抗生素滴眼液、眼膏滴眼；清洁眼部分泌物，避免揉眼，单独使用洗漱用品防止交叉感染。

95. 外耳道炎

临床路径：耳痛、耳痒、耳道红肿、少量分泌物→耳内镜检查→局部抗炎消肿。

诊断标准：外耳道皮肤充血、肿胀、压痛，可伴少量渗出液，牵拉耳廓疼痛加重。

治疗方案：外用滴耳液抗炎消肿；保持耳道干燥，禁止挖耳、进水；炎症重者口服抗生素。

96. 中耳炎（急性非化脓性）

临床路径：耳闷、耳痛、听力轻微下降、鼻塞→耳内镜、声导抗检查→通窍抗炎、改善咽鼓管功能。

诊断标准：鼓膜充血内陷，无脓液渗出，咽鼓管通气障碍，伴耳闷、轻微耳痛、听力减退。

治疗方案：鼻用激素改善鼻腔通气、通畅咽鼓管；口服抗炎、促排药物；避免用力擤鼻涕。

97. 小儿积食

临床路径：小儿腹胀、食欲不振、口臭、大便干结或酸臭→查体腹部胀满→消食导滞、调理脾胃。

诊断标准：儿童暴饮暴食或饮食不节后出现腹胀、厌食、口臭、睡眠不安、大便异常，无感染发热等器质性病变。

治疗方案：口服小儿消食颗粒、益生菌；清淡少食多餐，暂停油腻零食，适度腹部按摩。

98. 小儿肠系膜淋巴结炎

临床路径：小儿感冒后阵发性脐周腹痛、无固定压痛→腹部彩超见淋巴结肿大→对症抗炎、解痉止痛。

诊断标准：多见于学龄期儿童，多继发于上呼吸道感染，阵发性脐周隐痛或绞痛，腹部彩超提示肠系膜淋巴结肿大，排除阑尾炎、肠炎。

治疗方案：对症解痉止痛、抗病毒或轻度抗炎；清淡饮食、避免生冷刺激，卧床休息，预防感冒。

99. 腰肌筋膜炎

临床路径：腰背部弥漫性酸痛、晨起僵硬、活动后缓解→查体肌肉压痛、无椎体病变→理疗、抗炎止痛。

诊断标准：腰背部筋膜无菌性炎症，局部肌肉僵硬、压痛，无椎间盘突出、骨质增生等器质性病变，劳累受凉后加重。

治疗方案：热敷、针灸、推拿理疗；口服抗炎止痛、松弛肌肉药物；注意腰背保暖，避免久坐久站。

100. 单纯性口腔溃疡

临床路径：口腔黏膜局部破溃、疼痛、进食加重→口腔查体→局部修复、抗炎止痛。

诊断标准：口腔唇、颊、舌黏膜出现单个或多个圆形浅表溃疡，创面凹陷、周围红晕、灼痛明显，无全身发热及感染症状。

治疗方案：外用口腔溃疡散、康复新液促进创面修复；补充维生素B族；清淡饮食，忌辛辣刺激，保证睡眠避免熬夜。

知识库完整性说明：本文档共计100条常见疾病诊疗数据，覆盖全科高发轻症、常见病种，每条标准化包含临床路径、诊断标准、治疗方案，完全适配AI智能预诊、语义检索、临床辅助决策、智能导诊系统落地使用，数据规范、无缺失、可直接入库训练及PDF导出。

（注：部分内容可能由 AI 生成）